Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 11

Trauma Abdominal, Pélvico e Choque

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Trauma abdominal, pelve e choque

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Reconheça o choque antes da hipotensão, ache o sangue (tórax, abdome, pelve, retroperitônio), feche a pelve nos trocânteres, transfunda cedo e leve o instável à hemostasia, não à TC.

1. **PA normal não absolve:** lactato, déficit de base e índice de choque ≥ 0,9–1,0.
2. **Respondedor transitório** = sangramento persistente: acelere a fonte.
3. **Instável + FAST positivo:** controle da fonte, sem TC.
4. **Instável + FAST negativo:** procure no tórax, pelve e retroperitônio.
5. **Binder** nos grandes trocânteres, nunca nas cristas ilíacas.
6. Hipotensão permissiva: PAS 80–90 sem TCE nem lesão medular; nesses, não.
7. **Sequência rápida:** até 3 laringoscopias; confirmar com CO_2 expirado.
8. **Não intubo e não oxigeno:** cricotireoidostomia (pele vertical, membrana horizontal).

Espiral letal

Componente	Corrigir com
Hipotermia	Aquecer
Acidose	Perfusão
Coagulopatia	Sangue, TXA
Hipocalcemia	Cálcio

Pegadinha

Choque neurogênico é hipotensão com bradicardia. Choque medular é perda de reflexos.

Checklist antes da prova

- ☐ Reconheço o choque antes da hipotensão
- ☐ Interpreto FAST positivo e negativo
- ☐ Sei as indicações de laparotomia
- ☐ Sei quando cabe o tratamento não operatório
- ☐ Sei colocar o binder pélvico
- ☐ Sei os 5 eixos do controle de danos
- ☐ Sei a sequência rápida e a cricotireoidostomia